



MÓDULO 8

Abordagem integrada e inovação nas DCNT

Rui Poínhos

ruipinhos@utad.pt

Cecília Morais

ceciliam@utad.pt

Conteúdos

1. Promoção da saúde e intervenção multidisciplinar

- 1.1. Saúde, bem-estar e qualidade de vida
- 1.2. Da psicologia da saúde à intervenção nutricional nas DCNT
- 1.3. Abordagem multidisciplinar na saúde e na doença

2. Mudança de comportamentos em nutrição e saúde

- 2.1. Modelos de mudança comportamental
- 2.2. Comportamento alimentar: conceitos, avaliação e uso clínico

Modelos de mudança comportamental

- Que factores podem influenciar a mudança de comportamentos?
- De que formas podem ser integrados na gestão de doenças crónicas?



Modelos de mudança comportamental

- Explicação das relações entre pensamento e comportamento.
- Cada modelo apresenta vantagens e desvantagens em termos de explicação da adesão ou mudança comportamental:
 - Nenhum modelo se adapta a todas as situações;
 - Vantagem do recurso à combinação de vários modelos.
- Níveis de influência:
 - Intrapessoal:
 - Variáveis cognitivas que influenciam o comportamento individual;
 - Interpessoal:
 - Mudança baseada também nas acções de outras pessoas;
 - Social ou comunitário:
 - O comportamento influencia e é influenciado pelo ambiente social.

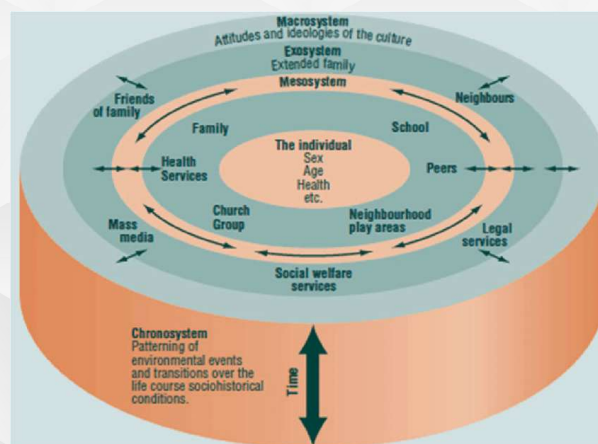
Modelo biomédico

- Doente visto como um recipiente e executor de regimes que deverão ser aceites e obedecidos.
 - Sujeito como mero executante de instruções.
 - Não valoriza as necessidades e preferências individuais.
- Não adesão entendida como resultado directo de uma aberração da personalidade do doente.
- Ajudou a compreender relações entre adesão e doença/ terapêutica e a melhorar a adesão.

Leal & Ribeiro, 2021

Teoria da perspectiva ecológica

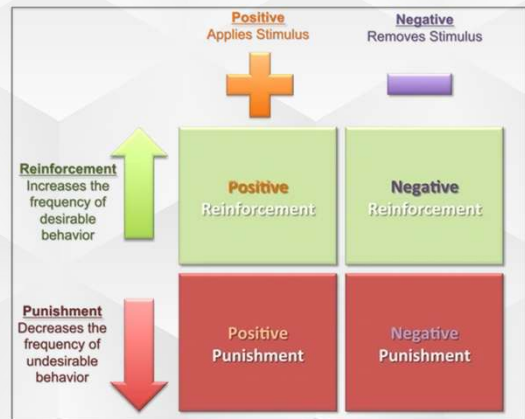
- O comportamento afecta e é afectado por múltiplos níveis de influência ecológica:



Bronfenbrenner et al., 1979; s Kochtitzky & Cracchiola, 2016

Condicionamento operante

- Exemplo mais comum da perspectiva comportamental.
 - O comportamento pode ter consequências positivas (reforço) ou negativas (punições).
 - Um comportamento recompensado tende a ser repetido; um comportamento punido tende a ser eliminado.
- ↓
- O comportamento pode ser controlado, recompensando ações desejadas e não recompensando ou punindo as não desejadas.



Skinner, 1938; Leal & Ribeiro, 2021

Condicionamento operante

- Reforço vs. punição:
 - Reforço com eficácia superior à punição (sobretudo a longo prazo);
 - O reforço indica o comportamento desejado;
 - Questões éticas da punição.
- Reforço positivo:
 - Eficaz sobretudo para aquisição de novos comportamentos; extinção mais lenta se o reforço for intermitente.
- Reforço negativo:
 - Eficaz sobretudo para comportamentos de fuga ou evitação; pode ser resistente à extinção se o estímulo for fortemente aversivo.

Skinner, 1938; Leal & Ribeiro, 2021

Condicionamento operante

- Vantajoso quando se pretende treino e aprendizagem de actividades instrumentais.
- Foco nos estímulos ou aspectos que desencadeiam o comportamento, nas recompensas que o reforçam, formação gradual ou padrão de comportamento, e automatização após repetição suficiente.
 - Não valorização dos factores cognitivos e emocionais.

Possibilidades de utilização
na gestão de DCNT?

Skinner, 1938; Leal & Ribeiro, 2021

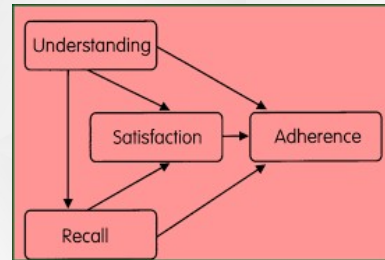
Abordagem comunicacional

- Doente visto como um iniciado que procura o conselho do especialista e o tratamento do profissional de saúde.
- A persuasão eficaz (adesão) depende de seis factores:
 - Produção da mensagem (incluindo informação sobre os objectivos e meios para os atingir);
 - Recepção da mensagem;
 - Compreensão da mensagem;
 - Retenção da mensagem;
 - Aceitação ou crença na mensagem;
 - Acção de adesão.

Leal & Ribeiro, 2021

Modelo da hipótese cognitiva de adesão

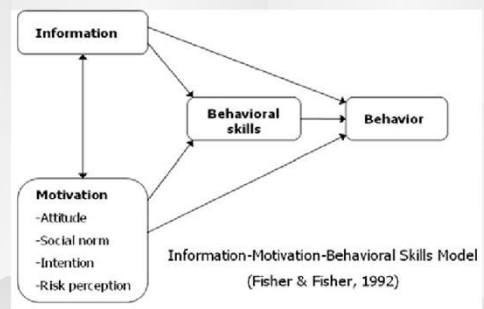
- A adesão é prevista com base na satisfação, compreensão da situação (causa, extensão e tratamento da doença) e capacidade de recordar a informação que lhe foi dada.
- A melhoria da adesão baseia-se na melhoria da comunicação:
 - Clareza, simplicidade;
 - Repetição;
 - Uso de informação escrita.



Ley, 1981

Modelo IMB/KAB

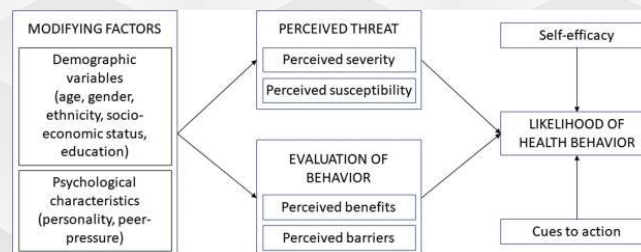
- Modelo de informação-motivação-comportamento/ conhecimento-atitude-comportamento
- Três componentes que devem ser orientados ou específicos para o comportamento desejado:
 - Informação:
 - Pré-requisito importante mas não suficiente;
 - Motivação:
 - Inclui a atitude individual face à adesão, o suporte social percebido, e as normas subjectivas (percepção do comportamento dos outros na mesma situação);
 - Comportamento:
 - Competências e habilidades, suporte social, estratégias de auto-regulação.



Fisher & Fisher, 1992

Modelo de crenças de saúde

- Modelo essencialmente individual e cognitivo.
- A motivação para adopção de comportamentos promotores da saúde depende de:
 - **Susceptibilidade** percebida da ameaça à saúde;
 - Percepção da **gravidade** da doença ou condição;
 - **Benefícios** percebidos vs. **dificuldades e barreiras**;
 - **Pistas** para a acção: **internas** (e.g. sintomas) e **externas** (e.g. programas de educação para a saúde)



Rosenstock, 1974; Becker, 1974; Leal & Ribeiro, 2021; Marks et al., 2011; Haller et al., 2008

Modelo de crenças de saúde

- Posteriormente foram sendo incluídas outras dimensões:
 - Motivação, auto-eficácia;
 - Características sociodemográficas (sexo, idade, grupo SE);
 - Factores psicológicos (e.g. influência da família, dos pares e de campanhas);
 - Factores estruturais (e.g. contacto prévio com a doença).
- A mudança implica alteração das crenças, devendo a percepção dos benefícios sobrepor-se aos custos.
- A intensidade das pistas para que o indivíduo entre em acção depende da gravidade e susceptibilidade percebidas:
 - Percepções de susceptibilidade e gravidade baixas implicam pistas mais intensas para gerar mudança.

Rosenstock, 1974; Becker, 1974; Leal & Ribeiro, 2021

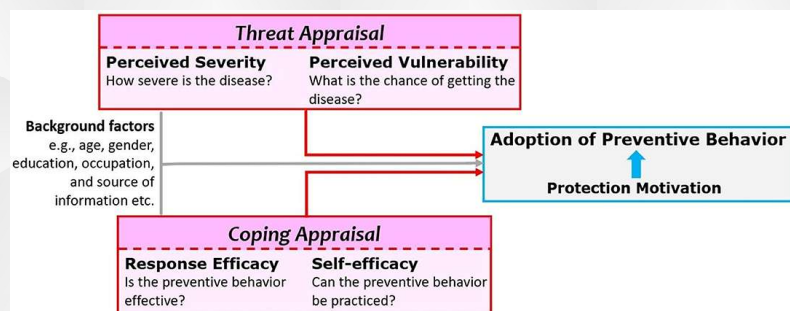
Modelo de crenças de saúde

- Críticas e limitações:
 - Mesmo estando reunidas todas as condições previstas no modelo, é necessário assegurar a colaboração;
 - Comportamentos mais relacionados com a percepção dos sintomas do que com os factores individuais (como sugerido no modelo);
 - Crenças de saúde tratadas como algo estático, sem considerar o desenvolvimento em função das experiências individuais;
 - Foco no processamento racional da informação (balanço entre aspectos positivos e negativos);
 - Ausência de aspectos emocionais (e.g. medo ou rejeição).

Leal & Ribeiro, 2021

Teoria da motivação protectora

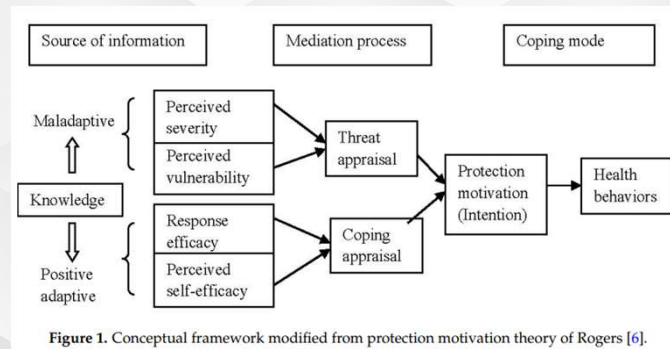
- Derivada do modelo de crenças da saúde.
- Factores preditivos da intenção de adoptar o comportamento:
 - Percepção de gravidade da doença;
 - Percepção de vulnerabilidade individual à doença;
 - Eficiência das respostas;
 - Auto-eficácia;
 - Medo (resposta emocional; incluído posteriormente).



Rogers, 1983; Lahiri et al., 2021

Teoria da motivação protectora

- Dois tipos de resposta:
 - Resposta adaptativa de intenções comportamentais;
 - Resposta de evitamento ou negação.



Rogers, 1983; Chamroonsawasdi et al., 2017

Teoria da acção planeada

- A mudança comportamental depende da **intenção** de mudança (causa imediata).
- A intenção de mudança é influenciada por:
 - **Atitudes** face ao comportamento (baseadas numa avaliação pessoal da acção e nas expectativas de determinado resultado);
 - **Normas subjectivas** (influências sociais, crenças normativas e importância de as seguir);
 - **Percepção de controlo** do comportamento (crença de poder realizar o comportamento com base no controlo interno ou externo).

Ajzen, 1985, 1988; Leal & Ribeiro, 2021

Teoria da acção planeada

- O comportamento é determinado pela informação sobre os riscos, benefícios e consequências.
- A tentativa de mudança comportamental implica que o indivíduo acredite que:
 - Os benefícios da mudança são superiores às desvantagens de um possível fracasso (atitude positiva);
 - As pessoas significativas (família, amigos, pares, profissionais de saúde) consideram a mudança adequada.
- Quanto maior a crença em recursos e oportunidades para mudar determinado comportamento, maior a crença de capacidade de mudança e mais facilitada está a mudança.

Ajzen, 1985, 1988; Leal & Ribeiro, 2021

Teoria da acção planeada

- A percepção de controlo tem influência directa na **intenção** e também indirecta no **comportamento**:
 - Com intenção constante e elevada percepção de controlo, o indivíduo actua por mais tempo e mais persistentemente, podendo antecipar obstáculos).
- A intenção prevê a **tentativa**, mas não o **desempenho real** do comportamento.
 - A execução depende do controlo em relação aos factores que possam impossibilitar a realização.
 - A percepção do controlo está relacionada com a capacidade de lidar com obstáculos e com o meio.

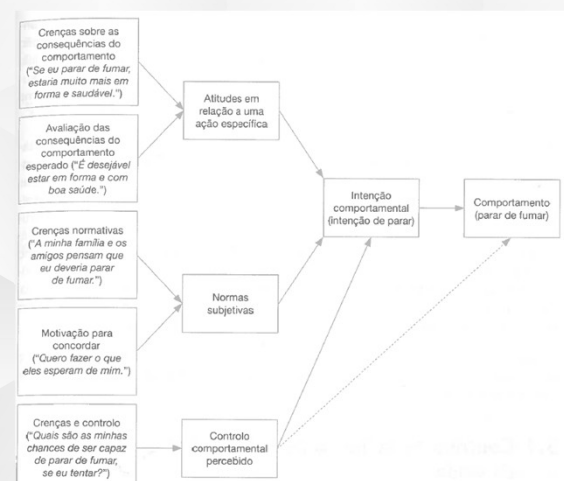


Fig. 5.1 Teoria de Ação Planeada, adaptada de Ajzen e Fishbein (1981, cit. por Roazzi et al., 2014)

Ajzen, 1985, 1988; Leal & Ribeiro, 2021

Teoria da acção planeada

- Relevante sobretudo para comportamentos complexos (e.g. hábitos alimentares).
- Críticas e limitações:
 - Suposição de que o comportamento é determinado por um processo de pensamento lógico e objectivo, com base na informação;
 - Factores externos às crenças não contabilizados (nomeadamente factores que moderem a relação entre intenção e acção).



- Importância de considerar o papel das emoções.

Ajzen, 1985, 1988; Leal & Ribeiro, 2021

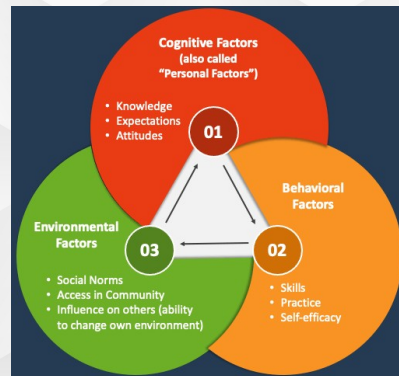
Teoria do locus de controlo para a saúde

- Três dimensões independentes do locus de controlo percebido para a saúde:
 - Interior; autoridades externas; acaso.
- Locus de controlo interno:
 - Maior probabilidade de comportamentos de promoção da saúde (desde que a pessoa valorize a saúde).
- Atribuição do locus de controlo ao acaso:
 - Maior probabilidade de comportamentos prejudiciais à saúde.
- Crença em autoridades externas:
 - Receptividade às mensagens dos profissionais de saúde; ou
 - Crença excessiva na ciência e consequente desleixo.

Waltson et al., 1978

Teoria cognitiva social

- Origem na teoria da aprendizagem social.
- Relação entre comportamento, processos cognitivos e dinâmica psicossocial subjacente aos comportamentos e métodos de promoção da mudança (modelo interpessoal).
- Factores envolvidos na mudança:
 - Comportamento potencial;
 - Expectativa de reforço e valor do reforço;
 - Situação psicológica.
- O comportamento é influenciado por:
 - Expectativas sobre resultados;
 - Expectativas de auto-eficácia.



Bandura, 1977, 1986; Leal & Ribeiro, 2021

Teoria cognitiva social

- Aplicação à psicologia da saúde:
 - Expectativas, incentivos e crenças que incentivam à mudança e a manter comportamentos saudáveis;
 - E.g. vantagens de adoptar o comportamento, expectativa de ser capaz de alterar o comportamento.
- Fortalecimento da auto-eficácia:
 - Simulação mental;
 - Persuasão verbal;
 - Interpretação das reacções fisiológicas associadas a sucessos ou insucessos.
- Experiências com resultados positivos aumentam a auto-eficácia:
 - Definição de objectivos simples e realistas.
- Níveis elevados de auto-eficácia promovem a intenção de mudança comportamental, a criação de planos de acção e a capacidade de iniciativa.
 - Quanto maior a auto-eficácia, mais ambiciosos os objectivos e a motivação para os atingir.

Modelagem
Aprendizagem
vicariante

Bandura, 1977, 1986; Leal & Ribeiro, 2021

Teoria cognitiva social

- Após iniciada a mudança, são necessárias estratégias de auto-controlo e auto-regulação para a sua manutenção e monitorização.

Table 1. Description of the self-regulatory mechanism proposed by the social cognitive theory of self-regulation [10,11].

Component	Mechanism	Descriptions
Self-monitoring	Feedback	Providing evidence of behaviour change progress
	Temporal proximity	Monitoring behaviour close in time to when it occurs
	Consistency	Self-monitoring regularly rather than intermittently
	Focus on success	Attending to achievement rather than failure
	Value of behaviour	Self-monitoring behaviour with perceived importance
	Control	Self-monitoring behaviour easy to deliberately modify
	Motivation	Desiring to change the monitored behaviour
	Self-diagnosis	Gaining insight through identifying behaviour patterns
Self-judgement	Social comparison	Relating self-progress with peers in similar situations
	Self-comparison	Contrasting ongoing progress with previous behaviour
	Statistical comparison	Evaluating progress by contrasting with normative data
	Modeling	Examples of others successful in changing behaviour
	Education/ reaction	Other's opinions or responses to inform judgement
Self-evaluation	Self-satisfaction	Gaining self-respect for goal completion or progress
	Self-incentives	Setting personal rewards for achieving progress
	External rewards	Setting tangible benefits for completion of a task or goal

Leal & Ribeiro, 2021; Tougas et al., 2015

Modelo do senso-comum da auto-regulação

- Sugere que, perante uma ameaça à saúde, um indivíduo actua como “cientista do senso-comum” (influenciado por sintomas, experiências passadas, contexto sociocultural e relações interpessoais), interpretando a ameaça e orientando o seu comportamento para a gerir e reestabelecer o seu estado de equilíbrio.
- Indivíduo como agente ativo, que tenta resolver problemas de saúde:
 - Forma representações cognitivas e emocionais da ameaça (e.g. diagnóstico);
 - Desenvolve estratégias de *coping* (enfrentamento) com base nessas representações;
 - Avalia os resultados dessas estratégias para ajustar comportamentos futuros.

Leventhal et al., 1984, 1998; Leal & Ribeiro, 2021

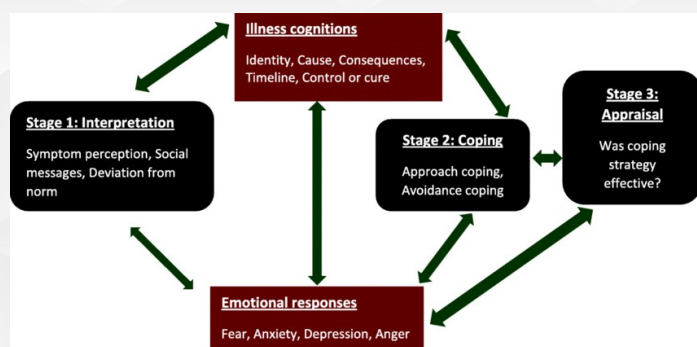
Modelo do senso-comum da auto-regulação

- Componentes das representações do risco de doença:
 - **Identidade:** O que é que tenho? Que nome tem a condição? Quais são os sintomas?
 - **Causa:** O que causou isto?
 - **Duração:** Quanto tempo durará? É algo agudo, crónico ou cíclico?
 - **Consequências:** Qual será o resultado? Que impacto tem na minha vida?
 - **Cura/ controlo:** Pode ser curado? Posso controlá-lo? O que pode melhorar isto?
- A ameaça pode ser necessária à mudança, mas não é suficiente, devendo ser acompanhada por um plano de acção:
 - Instruções claras para um desempenho eficaz;
 - Apoio na integração das mudanças na rotina diária.

Leventhal et al., 1984, 1998; Leal & Ribeiro, 2021

Modelo do senso-comum da auto-regulação

- A percepção do risco é mediada por variáveis cognitivas e emocionais.
- A avaliação pode levar à actualização das representações.
- As componentes das representações e as crenças sobre a eficácia do plano de acção condicionam as respostas emocionais e comportamentais.



Leventhal et al., 1984, 1998; Leal & Ribeiro, 2021; Igwesi-Chidobe et al., 2020

Modelo do senso-comum da auto-regulação

- As representações estão associadas a um plano de acção que torna o sistema de auto-regulação completo e coerente.
- Na perspectiva do indivíduo, esta coerência pode ser expressa por formulações “se ..., então ...”:
 - SE acredito que a doença é provocada por stresse, ENTÃO vou garantir que reduzo o stresse na minha vida.
 - SE acredito que a doença vai passar depressa, ENTÃO não preciso fazer o tratamento por muito tempo.
 - SE acredito que a doença só existe quando há sintomas, ENTÃO só faço o tratamento quando há sintomas.
- Importante **considerar as percepções e representações** da doença, estratégias de *coping* e seus efeitos nos resultados de saúde e **harmonizar sistemas de crenças** diferentes.
 - Efeitos no ajustamento, colaboração e adesão terapêutica, nomeadamente nas DCNT.

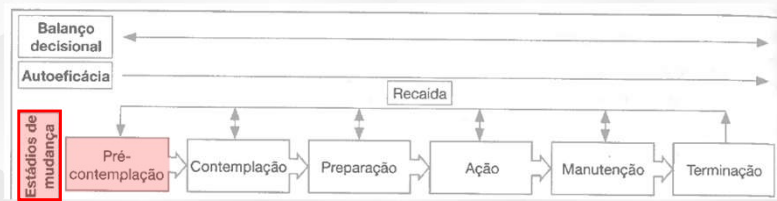
Leventhal et al., 1984, 1998; Leal & Ribeiro, 2021

Modelo transteórico

- Processo gradual e dinâmico de mudança, constituído por diferentes níveis de motivação/ disposição e de consciência em direcção à mudança.
- Quatro componentes principais:
 - Estádios de mudança;
 - Processo de mudança;
 - Balanço decisório;
 - Auto-eficácia.

Prochaska & Di Clement, 1982; Leal & Ribeiro, 2021

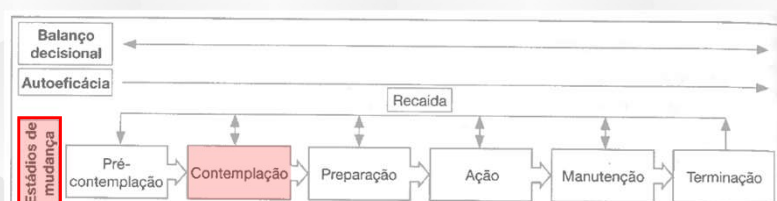
Modelo transteórico



- **Pré-contemplação:**
 - Ausência de intenção de mudança a médio prazo (6 meses);
 - O comportamento actual não é entendido como problemático, podendo haver pouca consciência das suas consequências;
 - Frequente evitamento do comportamento disfuncional (e.g. ler, falar sobre ele) por vezes associado a insucesso em tentativas anteriores de mudança ou falta de informação.

Prochaska & Di Clement, 1982; Leal & Ribeiro, 2021

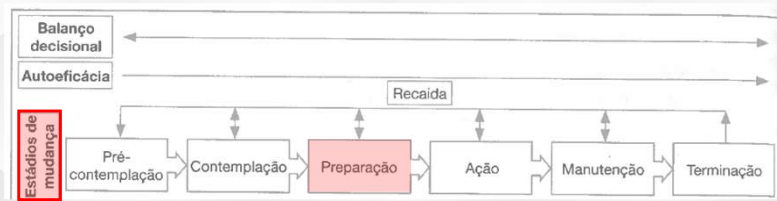
Modelo transteórico



- **Contemplação:**
 - Consciência do comportamento disfuncional e consideração da possibilidade de mudança (6 meses seguintes), mas sem compromisso de passagem à acção;
 - Ambivalência entre ganhos e perdas.

Prochaska & Di Clement, 1982; Leal & Ribeiro, 2021

Modelo transteórico

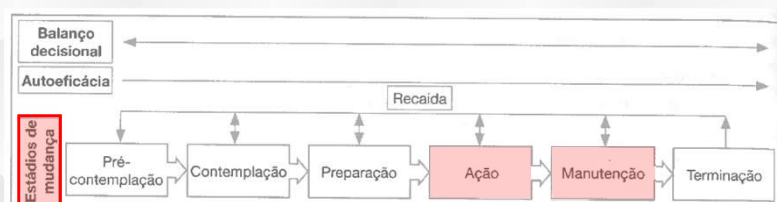


• Preparação:

- Compromisso com a mudança;
- Determinação de planos de mudança a implementar num futuro próximo (30 dias);
- Pequenas mudanças de aproximação ao comportamento.

Prochaska & Di Clement, 1982; Leal & Ribeiro, 2021

Modelo transteórico



• Acção:

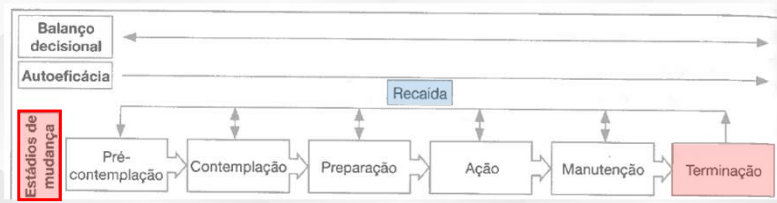
- Implementação de medidas pragmáticas e efectivas para adoptar o novo comportamento;
- Estádio com maior risco de recaída.

• Manutenção:

- Consolidação dos ganhos ocorridos no estágio de acção;
- Implementação de estratégias de prevenção de recaída.

Prochaska & Di Clement, 1982; Leal & Ribeiro, 2021

Modelo transteórico



- **Terminação:**
 - Automatização;
 - Ausência de necessidade de investimento activo na prevenção de recaídas.
- Estatuto positivo da recaída: fonte de informação e análise.

Prochaska & Di Clement, 1982; Leal & Ribeiro, 2021

Modelo transteórico



- **Balanço decisório:**
 - Avaliação das vantagens e desvantagens da mudança.
- **Auto-eficácia:**
 - Confiança na capacidade de mudança.

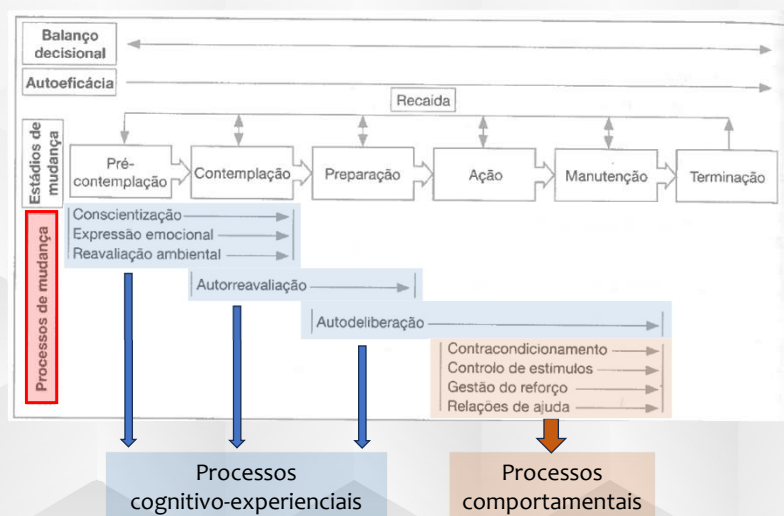
Prochaska & Di Clement, 1982; Leal & Ribeiro, 2021

Modelo transteórico

- Intervenção dependente do estágio:
 - Estádios 1 e 2 (pré-contemplação e contemplação):
 - Informação geral e sensibilização;
 - Intervenções em grupo;
 - Estádios 3 e 4 (preparação e acção):
 - Informação sobre o que mudar e como;
 - Estratégias práticas;
 - Acompanhamento personalizado e individual;
 - Estádio 5 (manutenção):
 - Menor necessidade de acompanhamento.

Modelo transteórico

Patient stage	Practitioner tasks
Precontemplation (Not ready)	Raise doubt and increase the patient's perception of the risks and problems with their current behaviour. Provide harm reduction strategies
Contemplation (Getting ready)	Weigh up the pros and cons of change with the patient and work on helping them tip the balance by: • exploring ambivalence and alternatives • identifying reasons for change/risks of not changing • increasing the patient's confidence in their ability to change
Preparation – action (Ready)	Clear goal setting – help the patient to develop a realistic plan for making a change and to take steps toward change
Maintenance (Sticking to it)	Help the patient to identify and use strategies to prevent relapse
Relapse* (Learning)	Help the patient renew the processes of contemplation and action without becoming stuck or demoralised
* Relapse is normalised in MI and is used as an opportunity to learn about how to maintain long term behaviour change in the future	



Modelo transteórico

- **Conscientização:**
 - Introdução e aumento de conhecimentos relacionados com as causas, consequências e soluções do comportamento disfuncional.
- **Expressão emocional:**
 - Expressão de aspectos afectivos associados ao comportamento disfuncional e ao processo de mudança.
- **Auto-reavaliação:**
 - Reavaliação cognitiva e emocional do confronto entre os valores e objectivos pessoais e o comportamento disfuncional, e auto-visualização prospectiva com e sem o comportamento disfuncional.
- **Reavaliação ambiental:**
 - Análise de como o comportamento disfuncional afecta o contexto físico e social próximo do indivíduo.
- **Auto-deliberação:**
 - Estabelecimento de compromisso para a mudança, incluindo a crença de que se é capaz de mudar.

Leal & Ribeiro, 2021

Modelo transteórico

- **Contra-condicionamento:**
 - Implementação activa de alternativas.
- **Controlo de estímulos:**
 - Restrição/ gestão de estímulos que possam desencadear o comportamento disfuncional.
- **Gestão do reforço:**
 - Modificação das contingências que mantêm o comportamento disfuncional (e.g. reforçar/ valorizar e ser reforçado/ valorizado por pequenas conquistas).
- **Liberação social:**
 - Distinguir e aumentar as alternativas na sociedade que promovam ou contribuam para a mudança.
- **Relações de ajuda:**
 - Construção de confiança e disponibilidade para aceitar o suporte de terceiros significativos durante o processo de mudança.

Leal & Ribeiro, 2021

Modelo transteórico

- Críticas e limitações:
 - Foco em aspectos comportamentais, considerando de forma limitada os aspectos biológicos que podem intervir nos processos de mudança;
 - Dificuldade de aplicação em situações que envolvem diversos comportamentos em simultâneo (e.g. comportamento alimentar).



- Integração em estratégias mais abrangentes.
- Utilização para mudança de hábitos específicos.

Leal & Ribeiro, 2021

Entrevista motivacional

- Estilo de aconselhamento centrado no cliente que visa a mudança do comportamento, ajudando a **exploração e resolução da ambivalência**.
- Conjugua constructos e técnicas de várias abordagens:
 - Terapia centrada no cliente; modelos cognitivo-comportamentais; psicologia social experimental.
- Conceitos fundamentais:
 - Ambivalência: relutância à mudança; conflito psicológico entre duas opções; expressão de barreiras entendida como ambivalência;
 - Prontidão: baseia-se nos estádios de mudança (modelo transteórico).

Entrevista motivacional

- Duas fases:
 - Estimulação da motivação para a mudança;
 - Estimulação do compromisso com a mudança.
- Princípios básicos:
 - Expressar empatia;
 - Expor a discrepância entre o comportamento actual e o desejado;
 - Evitar discussões;
 - Fluir com a resistência em vez de a enfrentar;
 - Estimular a auto-eficácia.

Entrevista motivacional

- Quatro passos/ fases/ processos:



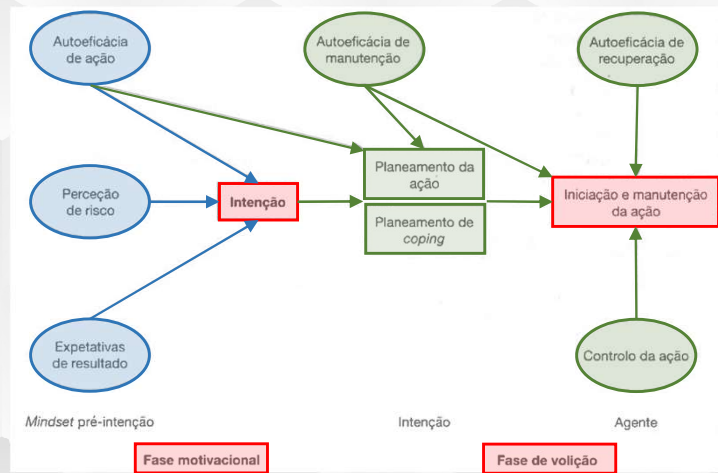
Phase	Description
Engaging	The provider and patient establish a working relationship. The provider makes it clear that he or she is not there to tell the client what to do.
Focusing	The patient-provider dyad settles on an agenda. The provider maintains patient autonomy by focusing on the patient's most pressing concern.
Evoking	The provider elicits the patient's personal reasons for change. When done successfully, the patient will be voicing the arguments for change.
Planning	This phase is marked by the shift from the "why" of change, to the "when" and "how." The provider guides the patient to come up with the best options for him- or herself.

	What are they?	Examples
O Open questions	Questions that do not invite brief answers such as 'yes', 'no'. They are used to encourage the person to do most of the talking and create a forward momentum that can be used to help the person explore change.	• 'How has the problem impacted on your life?' • 'In what ways would you like the problem to change?' • 'What would be different if the problem was not around anymore?'
A Affirmations	A way of building rapport and reinforcing open exploration, providing that they come across as genuine and sincere. Affirmations may be in the form of compliments or statements of appreciation and understanding.	• 'That's a really good point.' • 'I can see that is really important to you.' • 'It sounds like that was a really difficult experience.' • 'You're the kind of person who cares a lot for other people.'
R Reflective listening	A method of active listening whereby the therapist seeks to understand what the person means and then offers the idea back to the person (in a flat tone) in the form of a statement to check understanding.	• 'The depression has taken many things away from you and your family.' • 'You feel as though avoiding stressful situations doesn't help, but it's hard to know what else to do.'
S Summaries	A type of reflective listening, where the therapist reflects back a summary of what the person has discussed.	• 'I wonder if I could take a minute to check that I'm understanding things correctly ...' • 'So it sounds like you are saying that ... does that capture what we have just discussed?'

Modelo HAPA – Health Action Process Approach

- Modelo sociocognitivo.
- Objectivo de colmatar a lacuna entre intenção e comportamento:

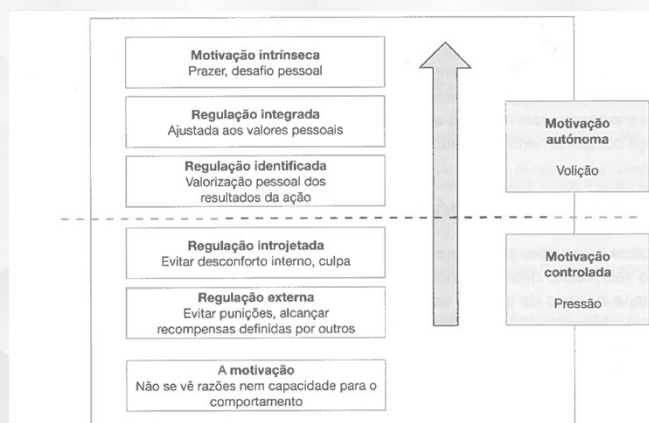
- Determinantes do início vs. da manutenção dos comportamentos de saúde;
- Processos de motivação pré-intenção vs. processos de volição pós-intenção.



Schwarzer, 2008; Leal & Ribeiro, 2021

Teoria de auto-determinação

- Perspectiva (meta-teoria) orgânica do indivíduo:
- Considerado elemento activo do seu próprio desenvolvimento psicológico;
- Procura responder aos desafios do contexto;
- Capaz de integrar as suas experiências na construção de um *self* coerente.



Fonte: Adaptado de Edmunds, Ntoumanis, Duda & Ntoumanis (2009).

Fig. 12.1 Contínuo de autodeterminação

Leal & Ribeiro, 2021